

机械磨削术治疗面部痤疮凹陷性瘢痕患者的护理要点及疗效观察

司桃, 范晓莉, 姜美娟, 钱云, 刁秀云

作者单位: 210042 江苏 南京, 中国医学科学院皮肤病医院 皮肤外科五病区

第一作者: 司桃, 女, 本科, 护师, 研究方向: 皮外科护理, Email: 1135113085@qq.com

通信作者: 范晓莉, 女, 本科, 副主任护师, 研究方向: 皮外科护理, Email: 321554161@qq.com

【摘要】 目的 探讨机械磨削术治疗面部凹陷性痤疮瘢痕的护理要点和疗效。**方法** 选择 2021 年 1 月至 2022 年 3 月于中国医学科学院皮肤病医院接受机械磨削术治疗的面部痤疮凹陷性瘢痕患者 29 例作为研究对象进行回顾性研究, 总结治疗和护理要点; 术前进行个性化心理护理及术前准备; 术中调试设备, 做好磨削护理、体位摆放、眼部护理, 监测异常生命体征及异常出血患者; 术后提供个性化饮食指导及术后指导, 随访 1 年, 统计皮损不良反应发生情况并调查患者满意度。**结果** 所有患者术中生命体征平稳, 无异常出血。所有患者术后随访 1 年后, 非常满意率为 79% (23/29), 满意率为 21% (6/29); 术后无感染, 伤口愈合良好, 均未出现新发瘢痕, 未出现明显疼痛、水肿、感染、红斑、色沉。**结论** 对机械磨削术治疗面部痤疮凹陷性瘢痕患者做好相应的护理能促进治疗顺利、达到良好疗效并降低并发症的发生。

【关键词】 机械磨削术; 痤疮; 瘢痕; 护理

doi: 10.3969/j.issn.2096-501X.2024.01.010

【文章编号】 2096-501X(2024)01-0041-05

Nursing care points and efficacy observation of mechanical dermabrasion in treating patients with depressed scarring of facial acne SI Tao, FAN Xiaoli, JIANG Meijuan, QIAN Yun, DIAO Xiuyun. (Area 5 of Department of Dermatological Surgery, Hospital for Skin Diseases, Chinese Academy of Medical Sciences, Nanjing 210042, China)

Corresponding author: FAN Xiaoli, Email: 321554161@qq.com

【Abstract】 Objective To explore the main points of nursing care and the effect of mechanical dermabrasion in the treatment of facial depressed acne scars. **Methods** Twenty-nine patients with facial depressed scars who received dermabrasion treatment from January 2021 to March 2022 in the Hospital for Skin Diseases of Chinese Academy of Medical Sciences were selected as the study subjects for a retrospective study to summarize the key points of treatment and care. Individualized psychological nursing and preoperative preparation were carried out before the operation. During the operation, the equipment was adjusted accurately to do well in dermabrasion care, intraoperative position and eye care, and patients with abnormal vital signs and abnormal bleeding was monitored. After the operation, personalized dietary guidance and postoperative guidance were provided, and the patients were followed up for 1 year to count the occurrence of adverse skin lesion reactions and to investigate patient satisfaction. **Results** All patients had stable intraoperative vital signs and no abnormal bleeding. After 1 year of postoperative follow-up of all patients, the great satisfaction rate was 79% (23/29), and the satisfaction rate was 21% (6/29). There was no postoperative infection, the wounds healed well, none of them showed new scarring, and there was no obvious pain, edema, infection, erythema, or discoloration. **Conclusions** The treatment of depressed facial acne scars by mechanical dermabrasion can ensure a smooth treatment, achieve good results, and reduce the occurrence of complications if appropriate nursing care is provided.

【Key words】 Mechanical dermabrasion; Acne; Scar; Nursing care

面部痤疮是青春期常见的慢性炎症性疾病,对于约 43% 的痤疮患者而言,痤疮瘢痕尤其是凹陷型痤疮瘢痕是常见的后遗症^[1]。这些痤疮和痤疮瘢痕均会影响患者的皮肤外观,进而影响患者的身心健康。因此,治疗和护理凹陷型痤疮瘢痕已成为痤疮患者后续治疗中的重点。现有常见的治疗方法包括激光治疗、化学剥脱治疗、射频治疗、微针疗法、填充疗法以及皮下分离术^[2-3],以上治疗对于大部分痤疮凹陷性瘢痕均有较理想的效果,但也存在一些并发症及不良反应,如较长时间的红斑期,易发生色素沉着及感染等,且治疗周期较长,治疗恢复过程缓慢。机械磨削术是对表皮和真皮浅层进行磨削的一种手术,应用于凹陷性瘢痕的治疗,具有损伤小、经济、恢复快等优势^[4]。然而,目前关于机械磨削术治疗面部痤疮凹陷性瘢痕的疗效与护理的临床研究数据较少。故本研究对行机械磨削术治疗的 29 例面部痤疮凹陷性瘢痕患者进行回顾性研究,现将治疗及护理要点报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取 2021 年 1 月至 2022 年 3 月在我院皮肤外科五病区住院的患者作为研究对象进行回顾性研究。纳入标准:经诊断为面部痤疮凹陷性瘢痕者;体征稳定、精神状态良好;知情同意并签署知情同意书。排除标准:合并脓疱疮、急性毛囊炎等细菌感染;合并单纯疱疹或有复发性疱疹病史者;瘢痕体质患者;硬结性痤疮、瘢痕疙瘩性痤疮患者;患有心、肝、肺、脑、肾等重要脏器疾病者;有严重心理障碍者。共纳入 29 例患者,其中男 11 例,女 18 例;年龄 18~42 岁,平均年龄 (28.0 ± 3.2) 岁;包括全面部瘢痕 16 例、双颊部瘢痕 9 例、额部瘢痕 4 例。

1.2 护理方法

1.2.1 术前护理

1.2.1.1 术前心理护理 凹陷型痤疮瘢痕通常为慢性病程,患者常伴有焦虑、抑郁状态。患者前来就诊时,迫切希望获得最好的治疗和最佳的疗效,同时又担心机械磨削治疗的不良反应,如出现红斑、色素沉着及新的瘢痕等。医护人员需做好入院宣教和术前宣教,详细介绍痤疮瘢痕的形成原因,讲解机械磨削术治疗凹陷型瘢痕的疗效,为患者展示既往机械磨削术治疗的病例图片,讲解手术过程、恢复过程及愈后等,解除患者术前焦虑及恐惧心

理,增强治疗及护理依从性。

1.2.1.2 术前患者准备 完善术前检查,排除手术禁忌;护士给患者备皮,充分暴露面部术区;术前用美兰标记瘢痕磨削的范围,瘢痕较深部位用美兰进行局部重点标记;术前与患者进行充分沟通,告知手术潜在风险及预后,签署手术知情同意书。

1.2.1.3 手术器械、物品准备 高速旋转磨削机(采用纺锤形状、不锈钢材质的金属磨头)、重组人表皮生长因子凝胶、无菌凡士林油纱、无菌纱布、生理盐水、庆大霉素注射液等。

1.2.2 术中护理

1.2.2.1 患者体位及眼部护理 患者术中取仰卧位,肩下垫软枕,用一次性手术帽和胶布包裹固定患者头发,并充分暴露面部术区;术中注意保护眼部,将一次性透明 3M 输液贴一分为二,剪切后粘贴双眼,防止术中消毒液、血液等物质误入患者眼中。

1.2.2.2 手术配合 ①设备调试:电动磨削机连接电源,将脚踏开关放置在合适位置,将电动磨削机手柄与金属磨头连接后锁紧,将磨头转速调整至 10 000 r/min。②麻醉配合:面部凹陷性瘢痕磨削一般采用全身麻醉。麻醉过程中护士应密切观察患者生命体征,防止患者出现呛咳、误吸。③磨削深度:磨削深度为真皮乳头层至点状出血,局部凹陷明显处再用磨头的远端进行局部点磨。④做好医护自我防护:在机械研磨的过程中,会产生大量血液、皮屑等混合物组成的颗粒,因此手术时要穿戴长袖隔离服,佩戴防护面具,以防止乙型肝炎、丙型肝炎、HIV 等病毒携带者对医护人员造成潜在威胁,因此磨削过程中医护人员要做好自我防护,防止交叉感染^[5]。

1.2.2.3 磨削护理 ①冲洗:磨削时护士用庆大霉素生理盐水冲洗磨削区域,将磨出的血液、皮屑冲洗干净;在磨削过程中,将无菌生理盐水滴注于磨削创面和磨头上,以有效降低局部温度^[6]。②创面处理:当磨削达到理想效果后,护士在磨削创面外涂重组人表皮生长因子凝胶,然后用凡士林油纱覆盖创面,最后外层用 7~8 层无菌纱布加压包扎,并在患者眼睛、鼻孔、口周的敷料上开小孔。

1.2.3 术后护理

1.2.3.1 体位 全麻术后回室应遵医嘱禁饮食 4~6 h,去枕平卧位 4~6 h;复醒后应抬高头部 15~30°或半卧位,促进血液循环,减轻面部肿胀和疼痛。

1.2.3.2 创面护理 ①手术后1~3 d:伤口渗血、渗液较多,每天更换外层加压包扎的敷料1~2次。②手术后5 d:去除外层加压的无菌纱布,充分暴露创面;在更换敷料时,使用生理盐水湿敷粘连部位,松解后再进行更换,勿强行撕扯纱布。③手术后10~14 d:内层的凡士林纱布会自然脱落,期间不要强行撕脱内层凡士林纱布,以免造成新生上皮剥脱、出血。

1.2.3.3 口腔护理及眼部护理 ①口腔护理:术后面部敷料加压包扎,患者张口困难,用棉签沾取生理盐水按顺序擦洗口腔以保持口腔清洁,清洗频率为2次/d。②眼部护理:面部磨削术后第1天:可能出现上下眼睑水肿,眼部分泌物变多,为防止结膜炎用0.25%氯霉素眼药水1次/d滴眼;眼部分泌物及时用湿纱布擦拭,以保持眼部清洁。

1.2.3.4 饮食指导 面部磨削患者术后创面渗出多、代谢率增强,而患者因面部敷料加压包扎而张口困难、难以进食。合理的营养支持可增加机体抵抗力,促进创面快速愈合,因此术后早期的饮食指导十分必要。①术后第1天:指导患者采用流质或半流质饮食,例如牛奶、蛋花汤、鱼汤等富含优质蛋白的食物。指导患者用吸管将流质饮食吸入,以减少口部活动带来的疼痛和摩擦。在进食或饮水时,指导患者保持口周敷料的清洁和干燥,以避免感染的发生。②术后2~3 d:面部会出现轻度水肿,面部纱布逐渐干燥,使面部产生硬面膜式面具感,张口较术后第1天有所变大,指导患者进食手指大小的食物。如碎牛肉、碎猪蹄、鸡蛋等富含蛋白的食品,还可食用肉末、鸡蛋面、肉汤及含维生素的蔬菜水果,如黄瓜、猕猴桃等。③术后5 d后:外层纱布已拆除,此时患者可正常进食,指导患者饮食上要注意合理搭配,忌烟酒、辛辣、刺激性食物。④磨削手术后:指导患者避免进食富含铜、铁、银、铋、汞等的食品,多吃含锌食品,如羊肉、猪肝、鸡心等。

1.2.3.5 并发症观察及护理指导 皮肤磨削术后常见并发症为疼痛、水肿、感染、红斑、色素沉着、新发瘢痕等,术后密切观察并对症处理。①疼痛:多数患者术后无疼痛或仅有轻微疼痛,护士密切关注疼痛评分,评估疼痛的性质和程度,必要时给予一般止痛剂(如氨酚曲马多片)。②水肿:术后1~3 d面部可出现水肿,一般无需特殊处理,可通过抬高头部15~30°来减轻水肿,如果水肿较严重可遵医嘱静滴地塞米松5 mg 临时1次。③感染:少数患者术后

会发生感染,磨削术后1~3 d伤口渗液较多,每天更换外层纱布,保持外层纱布清洁干燥,以防细菌繁殖发生感染;必要时给予抗生素治疗。④红斑:是术后不可避免的并发症,术后1~2个月自行消退,一般无需特殊处理,术后注意防晒,避免红斑加重。⑤色素沉着:出现率超过90%,个体差异较大,为暂时症状,通常于手术后3~6个月自行消失^[7]。术后可服用维生素C片1个月或静滴维生素C 1~2 g/d,连续3 d,同时外用氢醌霜、复方熊果苷乳膏、复方甘草黄酮乳膏、烟酰胺凝胶等药膏,出门注意物理和化学防晒。⑥新发瘢痕:瘢痕体质患者禁止进行机械磨削,磨削深度的控制是预防新发瘢痕的关键。磨削深度主要以达到真皮乳头层为止,若达到网状层的深部,术后多留有瘢痕^[7]。因此医生在磨削时对深度的控制十分重要,防止磨削深度过浅痤疮瘢痕复发,深度过深术后新发瘢痕。

1.2.4 出院指导

凹陷性痤疮瘢痕在临床实践中应该提倡“防重于治”的原则。健康宣教、生活指导和有效的炎症期处理都能显著减少瘢痕复发。

1.2.4.1 术后随访 机械磨削治疗一般只需进行1次。告知患者复诊的时间,即治疗后的1周、1个月和3个月内来医院复查,动态评估患者伤口恢复情况、观察有无红斑反应、色素沉着、瘢痕增生等并发症的发生。

1.2.4.2 术后注意事项 ①正确护肤:每日洁面2次,使用温和的洁面乳清洁皮肤,不建议化妆,可使用清爽型乳液,以免加重皮肤负担。为了避免皮肤出现色素沉着,不暴露在阳光下和光敏物质的环境中,同时也要尽量减少室外运动。建议在户外戴上口罩、宽边帽子,或者涂上防晒霜(SPF15~25, PA+~++)。②抗瘢痕治疗:伤口痊愈后,指导患者至少要进行3个月的抗瘢痕治疗,可外涂康瑞保、积雪苷霜乳膏等;创面愈合后,还应使用氢醌霜、烟酰胺凝胶等药至少1个月。应注意氢醌是一种光感性物质,需冰箱内低温避光保存,于夜间使用。③饮食指导:建议患者饮食清淡,避免油腻、辛辣、刺激性食物,适量摄入新鲜水果和蔬菜,并戒烟酒。

1.3 观察指标

1.3.1 临床疗效观察

术中观察:统计出现异常生命体征及异常出血的例数。

术后随访1年:观察皮损不良反应发生情况,统

计出现术后疼痛、水肿、感染、红斑、色沉及新发瘢痕感染的例数。

1.3.2 患者满意度评价

术后 1 年通过电话随访 29 例患者(有效随访率为 100%),患者采用研究者自制的凹陷性痤疮瘢痕磨削术后效果自我评价量表对自己的面部进行满意度评估,内容包括手术效果、不良反应、自我形象、自信心、生活质量,每项 0~20 分,总分 100 分,得分越高代表手术效果越好,根据得分评为 3 个水平:很满意(得分 ≥ 90 分)、满意(得分 60~89 分)和 不满意(得分 <60 分)。

2 结果

所有患者术中生命体征平稳,无异常出血。所有患者均进行术后 1 年电话随访,非常满意率为 79%(23/29),满意率为 21%(6/29);术后无感染,伤口愈合良好,均未出现新发瘢痕,未出现明显疼痛、水肿、感染、红斑、色素沉着。

3 讨论

面部痤疮凹陷性瘢痕是一种好发于面部的常见皮肤病,常由于局部炎症及治疗不及时导致皮肤全层破坏^[8-10]。凹陷性瘢痕不仅影响皮肤的美观,还会给患者带来很大的心理压力,甚至引发多种精神障碍^[11]。机械磨削作为治疗痤疮凹陷性瘢痕的一种经典技术,术后残存的皮肤附属器(毛囊、皮脂腺、汗腺)会迅速形成新的表皮,磨削不穿透网状真皮层,伤口几乎不留或极少留瘢痕而愈合^[12],对浅表凹陷性瘢痕疗效显著^[13]。机械磨削术需要在痤疮稳定后进行,机械磨削钻头通过对表皮和真皮的浅层破坏,刺激真皮深层皮肤中上皮的迁移生长作用,加快伤口的愈合,从而使皮肤变得平整、光滑,改善凹陷性瘢痕^[14]。然而,机械磨削术的短期损伤比较大,通过掌握合适的磨削深度,可有效避免瘢痕、红斑以及持续性色素沉着的出现^[15]。我科通过使用高速旋转磨削机对 29 例痤疮凹陷性瘢痕患者进行机械磨削术治疗,均未出现明显色素沉着、皮肤受损、光敏反应及新发瘢痕等不良反应,表明机械磨削术在治疗痤疮凹陷性瘢痕方面疗效佳且不良反应小。

良好的围术期护理对于进行面部机械磨削患者的预后至关重要。完善的术前物品准备及心理护理,可有效减少患者的紧张和恐惧,增强手术依

从性。磨削时及时冲洗创面使术区视野清晰且能有效降温,磨削后立即外涂重组人表皮生长因子凝胶,以缩短创面结痂及痂皮脱落时间,促进创面炎症的吸收,加快细胞生长发育速度,加速创面愈合^[16]。术中做好体位、眼部护理能有效保证患者安全,防止出现眼部损伤及误吸。术毕用凡士林油纱覆盖创面,维持创面湿润,使伤口实现湿性愈合^[17],阻挡细菌与创面接触,降低感染发生率。术后的饮食护理和并发症的观察对创面的恢复作用重大,通过早期饮食干预为患者提供充足的营养,不仅有效促进创面的愈合,还降低并发症的发生。术后创面护理、口腔及眼部护理,能有效减轻水肿和防止伤口感染。出院指导为患者出院后自我护理提供了依据,能有效地巩固面部磨削术的疗效。除术中严格控制磨削深浅度,严格无菌操作外,术后正确防晒及积极抗瘢痕治疗是磨削手术的关键^[13],能有效减少色素沉着及瘢痕,做好饮食管理及洁面护理能有效控制痤疮,从而避免痤疮瘢痕的产生。

综上所述,本文总结了机械磨削术治疗痤疮凹陷性瘢痕的护理要点,护理人员在护理过程中依据各护理要点给患者提供综合性护理,能有效提高临床疗效并降低术后并发症的发生。

参考文献:

- [1] Tan J, Kang S, Leyden J. Prevalence and Risk Factors of Acne Scarring Among Patients Consulting Dermatologists in the USA[J]. J Drugs Dermatol, 2017, 16(2): 97-102.
- [2] Boen M, Jacob C. A review and update of treatment options using the acne scar classification system[J]. Dermatol Surg, 2019, 45(3): 411-422.
- [3] Soliman YS, Horowitz R, Hashim PW, et al. Update on acne scar treatment[J]. Cutis, 2018, 102(1): 21, 25, 47-48.
- [4] Sugisawa R, Komatsu G, Hiramoto E, et al. Independent modes of disease repair by AIM protein distinguished in AIM-felinated mice[J]. Sci Rep, 2018, 8(1): 13157.
- [5] Surowitz JB, Shockley WW. Enhancement of facial scars with dermabrasion [J]. Facial Plastic Surgery Clinics of North America, 2011, 19(3): 517-525.
- [6] 肖调立, 徐毅, 何玮, 等. 皮肤磨削术结合薄皮片修复外伤性色素脱失和浅表瘢痕[J]. 中国美容医学, 2016, 25(6): 16-18.
- [7] 方方. 皮肤磨削术及其应用[J]. 中国美容医学, 2020, 29(4): 1-7.
- [8] 王艺潭. 痤疮后凹陷性瘢痕治疗的研究进展[J]. 临床与病理杂志, 2019, 39(11): 2544-2548.
- [9] 宋洋, 李珊山, 周俊峰. 痤疮后凹陷性瘢痕的分类及治疗方法[J]. 中国医学文摘(皮肤科学), 2015, 32(1): 44-50.
- [10] 刘娜, 陶小华. 凹陷性痤疮疤痕的形成机制研究进展[J]. 皮肤科学通报, 2019, 36(5): 545-548.

临床护理

健康行为过程理论护理模式在慢性牙周炎种植治疗患者中的效果评价

高敏, 陈珊珊, 谢玲玲, 王雪

基金项目: 南京医科大学科技发展基金面上项目(NMUSN202102)

作者单位: 210029 江苏 南京, 南京医科大学附属口腔医院(江苏省口腔医院) 门诊手术室

第一作者: 高敏, 女, 本科, 主管护师, 研究方向: 口腔种植护理, Email: 927099751@qq.com

通信作者: 陈珊珊, 女, 本科, 主管护师, 研究方向: 口腔种植护理, Email: 99931227@qq.com

【摘要】 目的 探讨健康行为过程理论(HAPA)护理模式在慢性牙周炎种植治疗患者中的效果评价。方法 选取南京医科大学附属口腔医院 2022 年 3 月至 10 月行种植义齿修复的慢性牙周炎患者 90 例,按随机数字表法分为两组,每组 45 例。对照组患者采用常规护理干预;观察组患者采用 HAPA 理论模型进行护理干预。干预后比较两组患者牙周指标(PLI、BI 和 PD),成年人健康自我管理能力测评表(AHSMRS)评分以及护理满意度。结果 观察组患者牙周指标明显优于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$);观察组患者的 AHSMRS 评分明显高于对照组($P<0.01$);观察组患者的护理满意度高于对照组($P<0.05$)。结论 HAPA 理论模型应用于慢性牙周炎种植治疗患者中,可以改善患者的牙周指标,增强自我管理能力,提高护理满意度,具有临床应用价值,值得推广。

【关键词】 健康行为过程理论; 慢性牙周炎; 种植术; 自我管理能力; 满意度

doi:10.3969/j.issn.2096-501X.2024.01.011

【文章编号】 2096-501X(2024)01-0045-04

Evaluation of the effectiveness of a health behavioural process theory-based care model in patients undergoing implant treatment for chronic periodontitis GAO Min, CHEN Shanshan, XIE Lingling, WANG Xue. (Outpatient Operation Theatre, Affiliated Stomatological Hospital of Nanjing Medical University/Jiangsu Provincial Stomatological Hospital, Nanjing 210029, China)

Corresponding author: CHEN Shanshan, Email: 99931227@qq.com

【Abstract】 **Objective** To investigate the evaluation of the effect of the HAPA theory of care model on the self-management ability of patients with chronic periodontitis treated with implants. **Methods** Ninety patients with chronic periodontitis who underwent implant denture restoration in Affiliated Stomatological Hospital of Nanjing Medical University from March 2022 to October 2022 were selected and divided into two groups according to the random number table method, with 45 cases in each group. The control group used conventional nursing intervention; the experimental group used the HAPA theoretical model for nursing intervention. Periodontal indicators (PLI, BI and PD), Adult Health Self-Management Scale (AHSMRS) scores and patient satisfaction

- [11] 黄亭壹,袁定芬.痤疮疤痕的治疗进展[J].应用激光,2015,35(6):737-742.
- [12] 宋国刚,睢恒春,黄威,等.皮肤机械磨削术 3491 例临床分析[J].中国中医药咨讯,2011,3(15):205.
- [13] 张倩,王焱,赵亮,等.机械磨削术在皮肤外科的临床应用[J].中国美容医学,2020,29(4):10-13.
- [14] 刘琴,郑楷平,吴剑波,等.面部微晶磨削术联合红蓝光治疗痤疮凹陷性疤痕的疗效[J].中华医学美容美容杂志,2020,

26(1):60-63.

- [15] 布文博,张珂,张倩等.机械磨削术治疗瑞尔黑变病的疗效观察[J].中国美容医学,2020,29(4):13-15.
- [16] 蒋威.重组人表皮生长因子联合点阵激光在痤疮疤痕治疗中的应用效果[J].山西医药杂志,2020,49(23):3291-3293.
- [17] Metzger S. Clinical and financial advantages of moist wound management[J]. Home Healthcare Nurse,2004,22(9):586-590.

[修回日期:2023-10-13][本文编辑:吴欣欣]